

트라마돌, 이제 1차 약제에서 빼야 할 때

BMJ Meta-analysis 2026.05 — 만성 통증에서 트라마돌은 임상적 의미 있는 효과 부재 + 심혈관 사건·골절·저나트륨 등 중대 부작용 위험 증가. 1차 진료 처방 재검토 필요.

한 문단·세 숫자로 요약

통증 감소 효과는 MCID 미만, 부작용 위험은 통계적으로 의미 있게 증가 — 위험-이익 역전



VAS 차이 (트라마돌 -7, 위약 -4)
MCID 10 mm 미달



중대 부작용
통계적 유의 증가



저자 결론
1차 약제 권고 부적합

핵심 메시지 — BMJ 메타분석 결론은 명확하다. "약한 오피오이드"라는 인식과 달리 트라마돌은 만성 통증에 임상적으로 의미 있는 진통 효과를 보이지 못한다. 반면 심혈관 사건·골절·저나트륨·세로토닌 증후군·의존성 위험은 의미 있게 증가한다. *위험이 효과를 능가*한다는 결론. 노인·심혈관 위험군·SSRI 복용자에서 1차 약제 사용은 위험하다.

왜 트라마돌 재평가가 필요한가

"NSAID 부작용 회피용 약한 오피오이드"라는 인식 — 실제로는 SNRI+오피오이드 이중 작용 + 복잡한 약리학

기존 인식과 실제

"약한 오피오이드"라는 통념 — NSAID 부작용 회피·노인·심장약 복용자에게 1차로 흔히 처방

실제 약리학 — Mu-opioid 수용체 + 세로토닌·NE 재흡수 억제(SNRI) 이중 작용. 단순한 약 X

CYP2D6 다형성 — ultra-rapid metabolizer에서 호흡억제·중독 위험 ↑. 한국인 다형성 약 1-2%

한국 처방 현황 — 트라마돌·복합제(울트라셋·트라마셋) 의원 처방 매우 흔함

2019 FDA 안전 경고 — 호흡억제·세로토닌 증후군·중독 위험 강조

BMJ 메타분석 — 누적 RCT 결과로 위험-이익 재평가, 1차 약제 권고 부적합 결론

임상 실무 충격 — 오랫동안 안전하다고 여겨진 약. 이제 처방·갱신 모두 재검토 필요.

⚠ 트라마돌 본질

Mu-opioid + SNRI

이중 작용 약물 — "약한 진통제" 아님. 세로토닌·NE 차단 → SSRI/SNRI 병용 시 세로토닌 증후군 위험

🔴 CYP2D6 변이

Ultra-rapid 호흡억제 ↑

유전자 다형성 — 일부 환자에서 활성 대사물(O-desmethyiltramadol) 폭증, 호흡억제·과량 위험

📈 한국 사용량

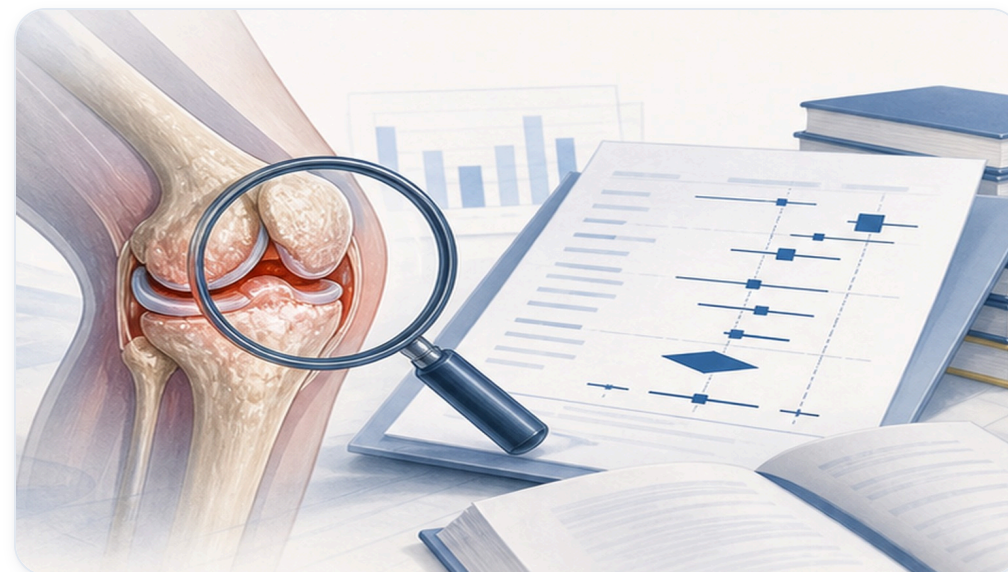
광범위 의원·정형·통증

울트라셋·트라마셋 복합제 포함 매우 흔한 처방. 노인 우선 사용군에 위험 noteworthy.

BMJ Systematic Review & Meta-analysis

만성 비암성 통증 RCT 다수 통합 · 효과 (VAS·NRS) + 안전성 (심혈관·골절·저나트륨·중독)
종합 평가

- **설계** Systematic review + meta-analysis (PRISMA 가이드라인 준수)
- **대상 RCT** 만성 비암성 통증 (척추·관절·신경병성·섬유근통 등)
- **중재** 트라마돌 (단독·복합제 포함) vs placebo / NSAID / 기타 진통제
- **1차 endpoint** 통증 감소 (VAS 0–100 mm), MCID 10 mm 기준 도달률
- **2차 endpoint** 기능 개선 (HAQ·SF-36) · 삶의 질 · 안전성
- **안전성 endpoint** 심혈관 사건 · 골절 · 저나트륨 · 세로토닌 증후군 · 의존성
- **이질성 평가** I^2 statistic, sensitivity analysis (지속기간·용량별)
- **편향 평가** Cochrane RoB · funnel plot · publication bias

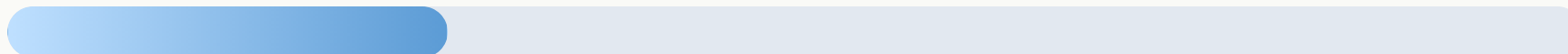


통증 효과 — MCID 미달 (임상적 의의 미약)

VAS 0-100 mm 척도. 트라마돌 -7, 위약 -4 → 차이 -3 mm. MCID 10 mm에 한참 미달.

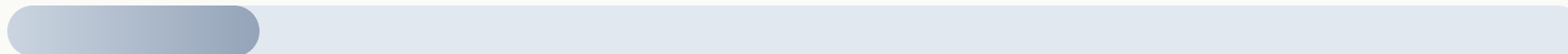
◆ 막대 폭 = VAS 0-25 mm 척도 비례 (오른쪽으로 갈수록 통증 감소 큼)

트라마돌



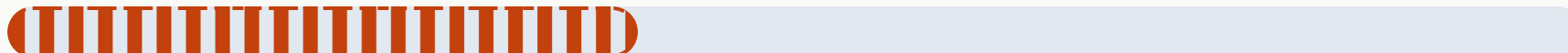
-7 mm

위약



-4 mm

MCID 임계



10 mm

핵심 — 두 군 모두 통증 감소가 있지만 트라마돌-위약 차이는 -3 mm에 불과 (개별 군 -7 / -4의 차이). 환자가 호전을 체감하는 MCID 10 mm에도 미달. "통계적 유의 ≠ 임상적 의미"의 대표 사례.

다른 endpoint 결과 — 기능 개선(HAQ-SF-36)·삶의 질 모두 위약 대비 임상적 의의 미약. MCID 도달자 비율은 트라마돌 30%, 위약 25% 수준 — 강한 위약 반응이 만성 통증 RCT의 일관 패턴 (placebo response >30% 흔함).

안전성 — 5가지 의미 있는 위험

위약·NSAID 대비 통계적 유의 증가. 노인·심혈관·SSRI 복용자에서 특히 ↑

위험	위약 대비	고위험군	기전
 심혈관 사건	의미 있는 ↑	CV 위험군	QT 연장·부정맥·심근경색 신호. 메커니즘 명확치 않으나 SNRI 작용 의심
 골절·낙상	의미 있는 ↑	65세+	중추 진정·어지러움 → 낙상. 노인에서 위험 가장 큼. 고관절·척추 골절
 저나트륨혈증	SIADH 유사	노인·이뇨제	Na <130 mEq/L 위험. 의식 저하·경련 가능. 이뇨제 병용 시 증폭
 세로토닌 증후군	잠재적 위험	SSRI/SNRI 병용	발열·근경직·자율신경 불안정. 응급 상황. 항우울제 흔히 동반 처방되어 위험
 의존성·금단	기존 인식보다 ↑	장기·고용량	물리적·심리적 의존 가능. 갑작스런 중단 시 금단 증상



기전 — 이중 작용 약물의 양면성

Mu-opioid 수용체 + 세로토닌·NE 재흡수 억제(SNRI) — 단순한 진통제 아닌 신경전달 다중 조절제



트라마돌 이중 작용 — 좌측: 뇌 mu-opioid 수용체 활성화(약한 opioid 효과). 우측: 시냅스 전후에서 세로토닌·노르에피네프린 재흡수 억제(SNRI 효과). 두 경로 모두 진통 기여하지만 동시에 부작용도 두 배. 중앙 하단 ⚠️ 심혈관 위험 표시.

이중 작용의 임상적 함의

약한 진통제 아님 — 단순 NSAID 대체로 인식되지만 신경계 다중 작용

SSRI/SNRI 병용 위험 — 세로토닌 농도 위험 수준 ↑ → 세로토닌 증후군

CYP2D6 의존성 — 활성 대사물(O-desmethytramadol)의 mu-opioid 친화도 200×. 개인차 큼

약물 상호작용 多 — CYP3A4·CYP2D6 동시 substrate, MAOI 금기

의존성 기전 — SNRI 성분이 의존성 강화 (단순 opioid 의존성 + 항우울제 금단 유사)

⚠️ **한국 현실** — 우울증·불안 환자가 SSRI/SNRI 복용 중에 통증으로 트라마돌 처방되는 경우 흔함. 세로토닌 증후군 위험 인지 필수.

고위험군 6가지 — 1차 약제 절대 회피

노인·심혈관 위험·SSRI 복용·신장·간기능 저하·CYP2D6 변이 — 처방 전 반드시 확인

RISK · 01

 65세+ 노인

낙상·골절 위험 가장 큼. 다약제·인지 기능·신장 ↓로 위험 증폭. 1차 약제 피하기.

RISK · 02

 심혈관 위험군

관상동맥질환·뇌졸중·HF·QT 연장. BMJ 메타에서 MACE 위험 ↑ 신호 분명.

RISK · 03

 SSRI/SNRI 병용

세로토닌 증후군 응급 — 발열·근경직·의식변화. 우울증 환자에 매우 흔한 조합.

RISK · 04

 신장 기능 저하

eGFR <30: 활성 대사물 추적 → 과량·호흡억제. 용량 조정 또는 회피.

RISK · 05

 간기능 저하

CYP3A4·CYP2D6 대사 저하. 발작 위험 ↑. Child-Pugh B-C에서는 회피.

RISK · 06

 CYP2D6 변이

Ultra-rapid metabolizer (소수): 호흡억제 폭증 위험. 한국인 1-2% 추정. 무증상 모름.

기존 처방 환자 — 재검토 우선순위

갑작스런 중단 X → 점진적 감량 + 대안 마련. 환자 안내·동의 필수

❗ 즉시 재검토

장기 복용 (3개월+) — 만성 비암성 통증으로
트라마돌 또는 울트라셋/트라마셋 지속 복용

고용량 (300+ mg/일) — 의존성·중독 위험
↑. 호흡억제·발작 위험

SSRI/SNRI 동시 — 우울증 또는 신경병성
통증 다중 약물 환자

65세+ 노인 — 낙상·골절 위험 + 다약제
polypharmacy

CV 동반 — 관상동맥·심부전·뇌졸중 병력

⚠ **점진적 감량** — 4-8주에 걸쳐 25%
단위로 감량. 갑작스런 중단은 금단 증상
(불안·진땀·근육통·구토).

✅ 환자 상담 시 메시지

"이 약은 약한 약이 아닙니다" — 환자 인식
교정

"통증 완전히 잡히는 게 아닙니다" — 효과
한계 솔직히 안내

"점진적으로 줄여 가겠습니다" — 갑작스런
중단 아님 안심

"비약물 치료가 1차" — 운동·물리치료·
인지치료 강조

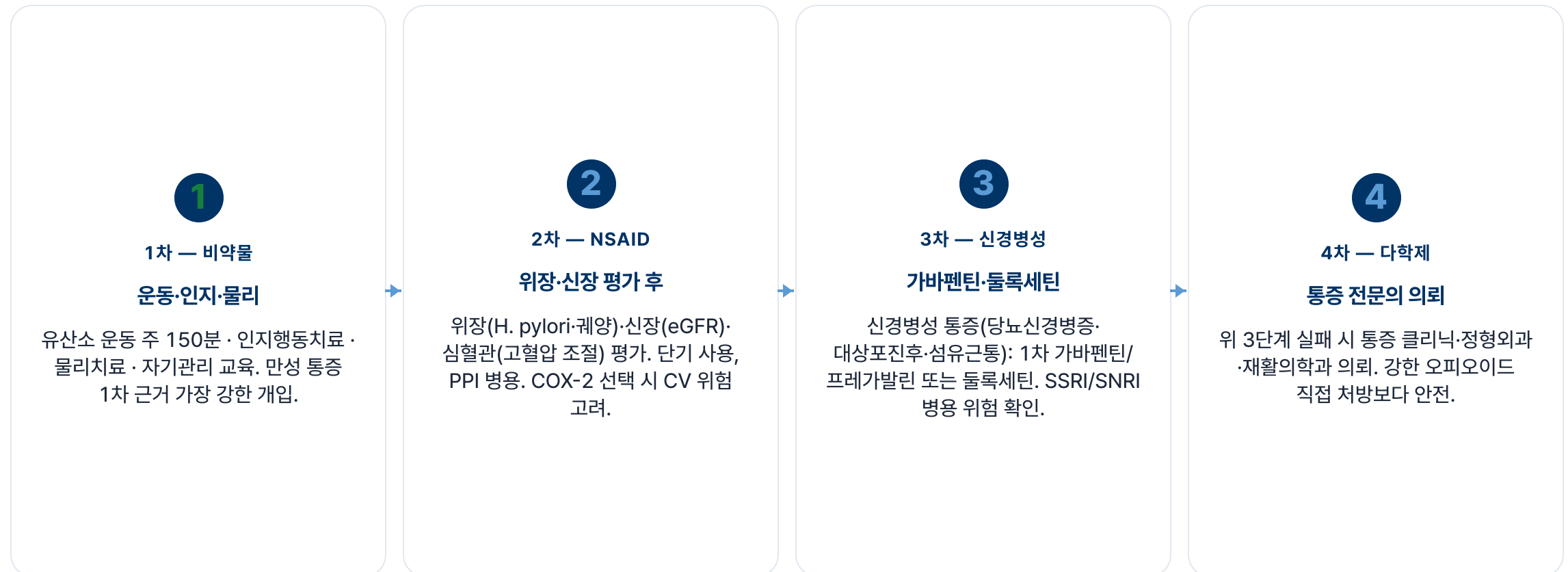
"NSAID 또는 다른 약으로 대체" — 위장·신장
평가 후 가능

🎯 **환자 만족도** — 솔직히 안내한 환자가
오히려 협조도 ↑. 다학제 통증 관리(운동·
심리·물리치료)로 전환 시 만성 통증 개선
효과 더 좋음.



대안 4단계 전략

비약물 → NSAID(평가 후) → 신경병성 통증 약 → 다학제 의뢰. 트라마돌은 마지막 선택.



한계와 주의사항 8가지

메타분석의 한계와 임상 적용 시 고려사항 — 균형 잡힌 해석 필요

⚠ **포함된 RCT 이질성** — 통증 종류(척추·관절·신경)·지속기간·용량 다양. I^2 statistic 높음 → 적용 시 주의

⚠ **단기 위주** — 대부분 <12주 RCT. 장기(6개월+) 효과·안전성 자료 부족

⚠ **급성·암성 통증 별도** — 메타 결론은 만성 비암성 통증에 한정. 급성·암성 통증에는 적용 X

⚠ **CYP2D6 다형성 영향** — 개인차 큼. 일부 환자에서 매우 효과 클 수도 있음

⚠ **플라시보 반응 강함** — 만성 통증 RCT 공통 — 위약군도 ~40% 반응. 트라마돌-위약 차이 더 작아 보임

⚠ **대안 부족 현실** — NSAID 금기 환자에서 옵션 제한. 다른 강한 오피오이드는 더 위험

⚠ **점진적 감량 어려움** — 장기 복용자에서 4-8주+ 감량 일정 필요, 환자 협조 필수

⚠ **다학제 의뢰 인프라** — 통증 클리닉·물리치료 접근성 지역별 격차 — 의원 단독 해결 어려움

1차 진료 Take-home — 4가지 핵심

트라마돌 처방 패턴 즉시 변경할 임상적 요약

1 트라마돌은 만성 통증 1차 약제에서 **빼야 한다** — 효과 MCID 미달 + 부작용 위험 의미 있는 증가

2 특히 노인·심혈관·SSRI 복용자에서 위험-이익 역전 — 1차 약제 절대 피해야 함

3 대안 4단계: 비약물 → NSAID(평가 후) → 가바펜틴/둘록세틴 → 다학제. 트라마돌은 마지막

4 기존 환자는 점진적 감량 + 대안 마련 후 중단. 4-8주 25% 단위 + 환자 안내 동의



다시 보기 — 슬라이드 링크 QR